GERENCIA
DE ATENCIÓN INTEGRADA
DE ALBACETE

sescam
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha

GUÍA DE AUTOCUIDADOS PARA PERSONAS CON ESCLEROSIS MÚLTIPLE

GUÍA DE ACOGIDA AL PACIENTE.

UNIDAD DE ENFERMEDADES DESMIELINIZANTES DEL HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ALBACETE

ÍNDICE:

1. ¿QUÉ ES LA ESCLEROSIS MÚLTIPLE?

2. ¿CUÁLES SON LOS SÍNTOMAS DE LA EM?

3. ¿CÓMO EVOLUCIONA LA ENFERMEDAD? TIPOS DE EM.

4. ¿CÓMO SE DIAGNOSTICA LA EM?

5. ¿Y AHORA QUE? TRATAMIENTOS.

6. EMBARAZO Y EM.

7. ¿QUÉ PUEDO HACER YO? AUTOCUIDADOS.

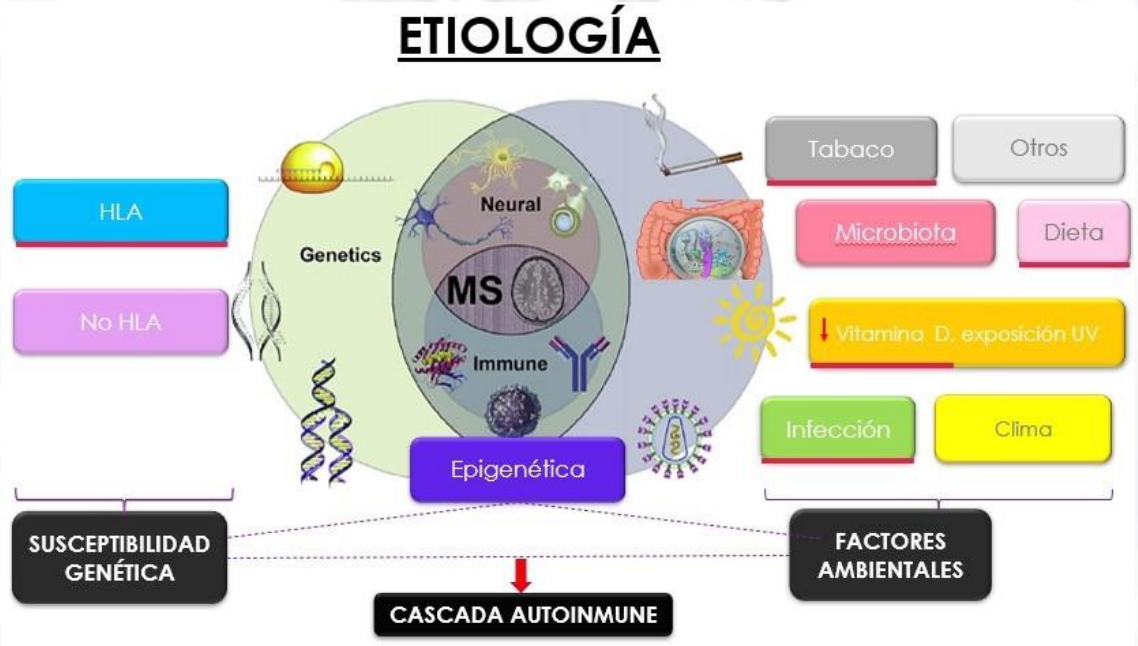
8. PRÁCTICA CLÍNICA HABITUAL EN LA UNIDAD DE ENFERMEDADES DESMIELINIZANTES.

9. ASOCIACIONES DE PACIENTES.

1 ¿QUÉ ES LA ESCLEROSIS MÚLTIPLE?

La esclerosis múltiple (EM) es una enfermedad crónica desmielinizante que afecta al sistema nervioso central (formado por el cerebro y la médula espinal). Es una enfermedad autoinmune, lo que quiere decir que nuestro sistema inmunológico, que normalmente defiende al organismo de virus y bacterias, ataca de forma errónea la vaina de mielina que recubre los nervios (desmielinizante). Esto dificulta la transmisión de los impulsos nerviosos y altera la comunicación entre neuronas.

Las zonas afectadas por la destrucción de la mielina se conocen como lesiones o placas y aparecen en diversas zonas del sistema nervioso como zonas endurecidas que se asemejan a una cicatriz o esclerosis. Estas lesiones, además, se producen en diferentes momentos. Por todo esto, los síntomas de la enfermedad y el momento de su aparición varían de una persona a otra.

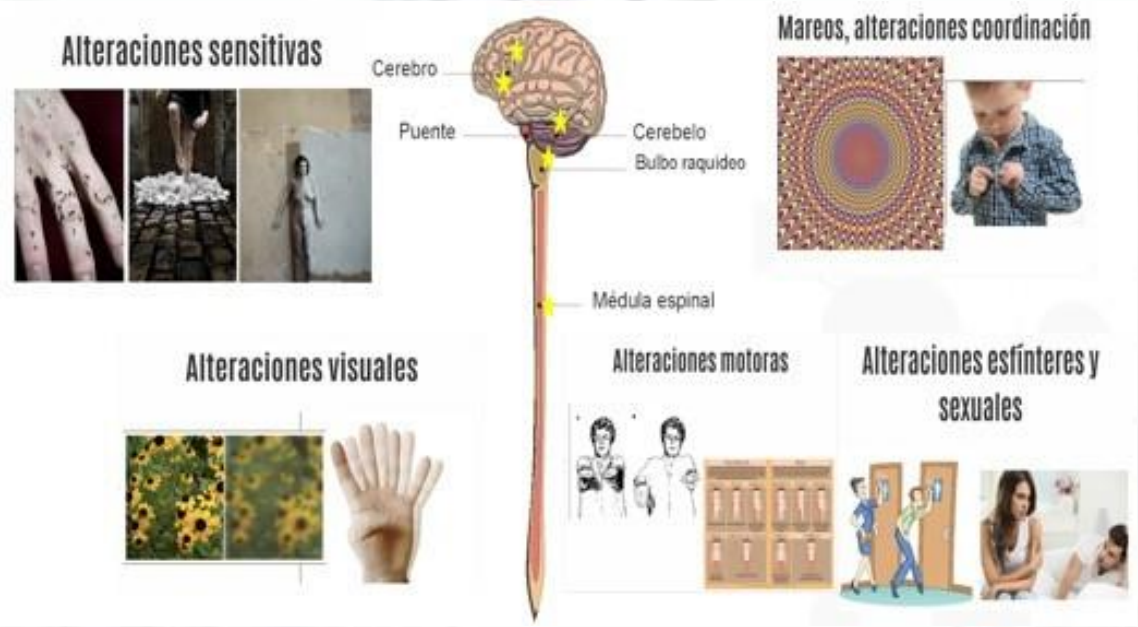


La causa (etiología) de la EM es desconocida. Sin embargo, sí se conocen múltiples factores que facilitan su aparición. Existe cierta predisposición genética sobre la que actúan determinados factores ambientales, dando lugar al inicio de la enfermedad (infección por virus de Epstein-Barr, bajos niveles de vit. D, tabaquismo, obesidad en la infancia/adolescencia…).

2. ¿CUÁLES SON LOS SÍNTOMAS DE LA EM?

Varían de una persona a otra, y en la misma persona a lo largo de la evolución de la enfermedad. Dependen de las áreas del sistema nervioso lesionadas y pueden aparecer de forma repentina o lenta:

a. Trastornos visuales.
b. Alteraciones de la sensibilidad.
c. Alteraciones del equilibrio y de la marcha.
d. Problemas motores.
e. Problemas sexuales.
f. Problemas de vejiga e intestinales.
g. Trastornos emocionales.
h. Fatiga.
i. Trastornos cognitivos.

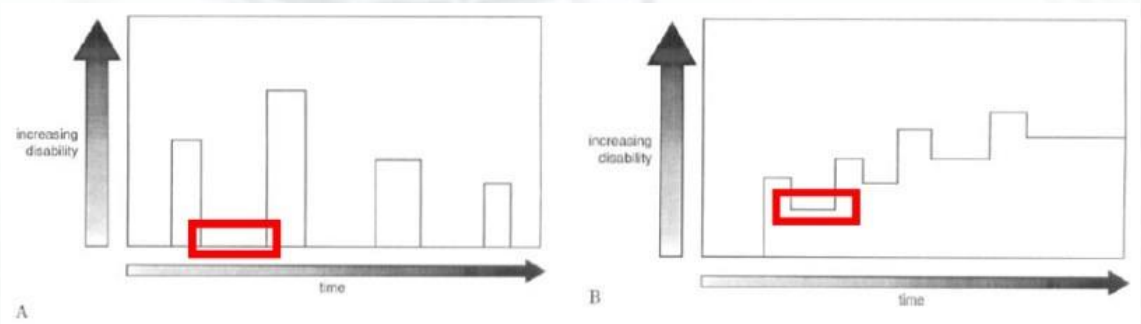


Las manifestaciones de la EM muchas veces aparecen en brotes, que se definen como la aparición de nuevos síntomas o el empeoramiento de alguno preexistente durante más de 24 horas y que deben estar separados al menos 30 días del síntoma previo. Es importante diferencial un brote de un pseudobrote. Este último supone el empeoramiento de un síntoma que ya existía debido a la presencia de una circunstancia que lo intensifica como puede ser el calor, la fiebre o una infección (respiratoria, urinaria las más frecuentes). Al corregir el factor desencadenante el paciente vuelve a su situación anterior.

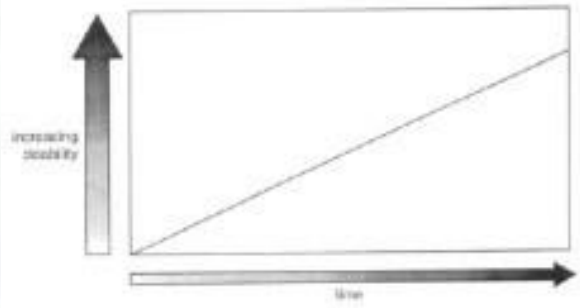
3. ¿CÓMO EVOLUCIONA LA ENFERMEDAD? TIPOS DE EM.

Clásicamente se han diferenciado varias formas clínicas de EM, aunque en los últimos años, la tendencia es considerar todas las formas clínicas como una misma entidad en la que en unos pacientes predomina la inflamación y en otros la degeneración, pero ambas formas pueden coexistir en un mismo paciente con un predominio de una u otra en función del momento evolutivo.

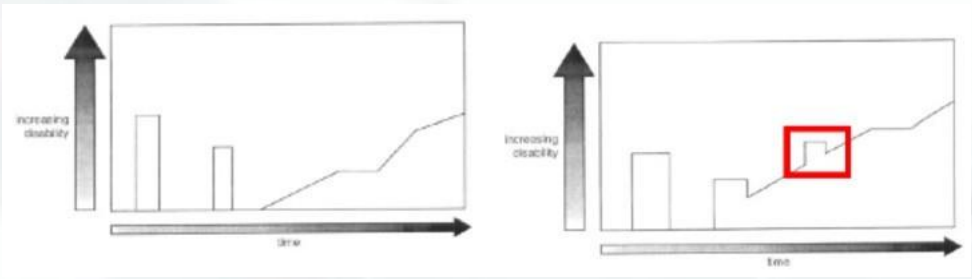
- EMRR (remitente-recurrente). Es la más frecuente y se caracteriza porque se manifiesta por periodos de recaída (brotes). Estos síntomas pueden durar desde días hasta semanas y su recuperación puede ser total o parcial; en este último caso, podrían quedar síntomas residuales (secuelas).



- EMPP (primaria progresiva). Presenta una evolución más o menos constante desde el principio de la enfermedad, sin poder identificar claros brotes a lo largo de la enfermedad



- EMSP (secundaria progresiva). Tras un periodo inicial remitente recurrente (en brotes) la enfermedad evoluciona de una forma progresiva, independientemente de que tengan o no brotes con posterioridad.



4 ¿CÓMO SE DIAGNOSTICA LA EM?

El inicio de la enfermedad puede tener lugar con síntomas leves y desaparecer, con lo que el paciente puede no llegar a consultar en estos momentos iniciales. Por tanto, al diagnóstico no es infrecuente que el paciente haya sufrido ya síntomas de la enfermedad en los meses o años previos.

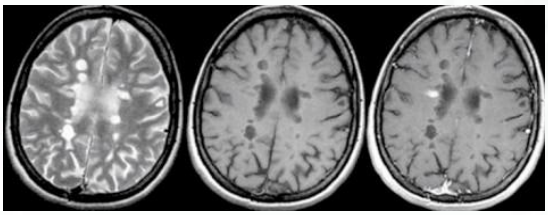
El diagnóstico de EM se basa en la combinación de los síntomas recogidos en la historia clínica y los resultados de varias pruebas diagnósticas. Es importante descartar otras enfermedades con síntomas similares, lo que se conoce como un diagnóstico de exclusión. Para ello, se realizan las siguientes evaluaciones:

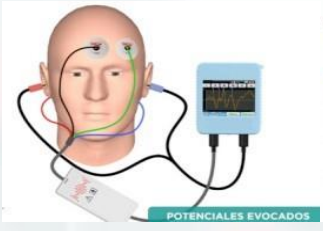
- **Historia clínica completa**. El neurólogo recopilará información sobre los síntomas (cuándo comenzaron, cómo han evolucionado, etc.), antecedentes personales y familiares, y realizará una exploración física y neurológica detallada.
- **Analítica de sangre completa**.
- Resonancia magnética de cerebro y médula espinal
- **Punción lumbar**: Para analizar el líquido cefalorraquídeo y buscar indicadores de inflamación o daño en el sistema nervioso central.
- **Potenciales evocados multimodales**: el estado de las vías nerviosas, como las visuales, sensitivas, auditivas y motoras.

Estas pruebas se pueden realizar estando el paciente ingresado o de forma ambulatoria a través de la consulta externa de Neurología.

Finalmente, para confirmar el diagnóstico de EM, se utilizan los criterios de McDonald. Estos criterios establecen que deben demostrarse al menos dos episodios de la enfermedad (brotes) en diferentes localizaciones del sistema nervioso (diseminación en el espacio) y en momentos distintos (diseminación en el tiempo), una vez descartadas otras posibles enfermedades











5. ¿Y AHORA QUÉ? TRATAMIENTO

Aunque actualmente no hay ningún tratamiento que cure la enfermedad, en los últimos años han aparecido fármacos que consiguen modificar su evolución.

Existen muchas variedades de tratamiento, tanto farmacológico como de rehabilitación. El tratamiento debe ser personalizado, ya que la enfermedad varía significativamente entre los pacientes en cuanto a síntomas, intensidad y secuelas.

Una vez confirmado el diagnóstico, el neurólogo informará sobre las opciones terapéuticas disponibles, orientando sobre la más adecuada según la actividad de la enfermedad, los planes personales (como el deseo de embarazo) y otras características. Esta decisión siempre se toma de forma compartida, consensuando las recomendaciones médicas con las preferencias del paciente.

En algunos casos, puede ser necesario usar medicamentos que actúa sobre las defensas (inmunosupresores). Si es así, se solicitará la valoración en Medicina Preventiva para actualizar el estado vacunal del paciente.

- TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO:

1.- Modificadores de la enfermedad:

Consigue reducir la frecuencia, duración e intensidad de los brotes. Existen 2 tipos fundamentales:

Inmunomoduladores: Modifican el sistema inmunitario para prevenir la inflamación y la destrucción de la mielina. Principalmente se reservan para pacientes con una enfermedad de baja actividad.

Inmunosupresores: Reducen el número y la actividad de las células inmunitariasque median el daño de la enfermedad. Se utilizan cuando la enfermedad es más activa.

También se pueden clasificar según la vía de administración:

Vía / Eficacia	Moderada ("Primera línea")	Alta ("Segunda línea")
Inyectable Intramuscular	Interferón-β 1-a (*Avonex*)	
Subcutáneo	IFN-β 1-a (resto) y 1-b Acetato de glatiramero (*AG*)	Natalizumab (*NTZ*) AntiCD20: ofatumumab (*OFM*)
Oral	Teriflunomida (*TRF*) Fumaratos (dimetil-*DMF*/diroximel-*DRF*)	Moduladores del receptor S1P Cladribina (*CLD*)
Intravenosa		Natalizumab (*NTZ*) AntiCD20: ocrelizumab (*OCZ*), * Alemtuzumab (*ALZ*)

Las características particulares de cada tratamiento, eficacia, necesidad de monitorización y efectos adversos se plantearían en la consulta con el neurólogo. Para más información se puede consultar o solicitar información sobre la *Guía de manejo de tratamientos modificadores de la esclerosis múltiple CHUA.*

2-. Tratamiento de brotes agudos:

Se pueden usar corticoides (orales – en pastilla - o intravenosos) aunque no siempre son necesarios. Esto depende de la intensidad del brote y del riesgo/beneficio de tomarlos.

3.-Tratamiento sintomático:

Tienen como objetivo aliviar los síntomas asociados a la EM, como dolor, espasticidad, depresión, problemas de marcha, entre otros. Existen varios fármacos para cada tipo de síntoma. Su objetivo principal es mejorar la calidad de vida del paciente.

TRATAMIENTO REHABILITADOR INTEGRAL:

El tratamiento rehabilitador complementa la terapia farmacológica y está dirigido a mejorar la calidad de vida del paciente, considerando aspectos físicos, emocionales y sociales. Este tipo de tratamiento es multidisciplinar e incluye la colaboración de profesionales especialistas en fisioterapia, terapia ocupacional, psicología, trabajo social, enfermería, urología, digestivo, etc.

El objetivo es proporcionar una atención integral que permita al paciente mantener la mayor autonomía y bienestar posibles en su vida diaria.

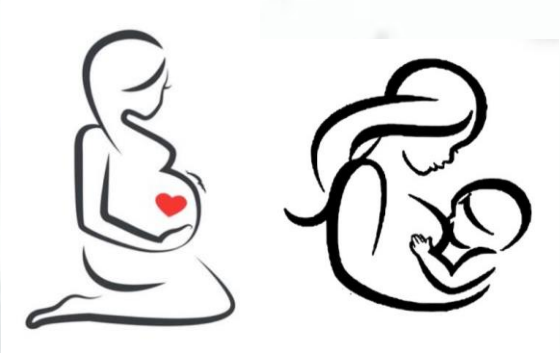
6. EMBARAZO Y EM.

La planificación familiar y la maternidad tienen cabida dentro de la EM. Para asegurar el mejor control de la enfermedad posible y evitar el impacto de los tratamientos en el embarazo es preciso recibir el asesoramiento apropiado por parte del médico en cada momento. Por tanto, es muy beneficioso ir manifestando los deseos de descendencia y llevar un acompañamiento estrecho en cada fase.

Los anticonceptivos orales no parecen modificar el curso de la enfermedad, pero hay que tener en cuenta las posibles interacciones con otros fármacos que esté tomando. Es muy importante informar al médico si se están tomando y consultar su impacto en los tratamientos de la EM.

En caso de deseo de gestación es muy beneficiosa la planificación del embarazo junto con el especialista, ya que muchos de los tratamientos están contraindicados durante el embarazo. El objetivo es conseguir la concepción cuando la enfermedad esté estable y así disminuir los riesgos del tratamiento y la enfermedad sobre la madre y el feto.

Las mujeres con EM pueden tener un embarazo normal, no hay riesgos adicionales para el feto, y en general la aparición de brotes y síntomas mejora durante el embarazo, puesto que se produce un cambio en el sistema inmunológico de la mujer.



7. ¿QUÉ PUEDO HACER YO? AUTOCUIDADOS

El autocuidado es esencial para las personas con esclerosis múltiple. Existen algunas pautas que pueden ayudar a los pacientes a mantener su bienestar físico, emocional y social, siempre adecuado a la intensidad de los síntomas del paciente. Habrá pacientes con un impacto mínimo de la enfermedad. En ellos, no será necesario adecuar su actividad. Por el contrario, aquellos pacientes con una afectación mayor deberán adecuar la actividad a sus capacidades. Las siguientes recomendaciones tienen su utilidad en aquellos pacientes que presentan alguno de los síntomas indicados:

1. Control de la Fatiga

Planificación de actividades: Organizar el día de manera que las tareas más exigentes se realicen en el momento del día en el que se esté más descansado (suele ser por la mañana).

Hacer descansos frecuentes durante las actividades.

Sueño reparador: Un buen descanso nocturno es esencial para combatir la fatiga. Es recomendable mantener una rutina de sueño estable.

Evitar el calor: Disminuir la temperatura ambiental, las vestimentas pesadas, beber agua fría o una ducha fresca puede ayudar a prevenir el aumento de los síntomas.

2. Manejo de síntomas específicos:

Trastornos urinarios: En caso de existir episodios de incontinencia urinaria, pueden prevenirse programando visitas al baño cada 2-3 horas e intentar aumentar progresivamente los intervalos. Es mejor beber pequeñas cantidades de agua a lo largo del día, que mucha cantidad de una vez. También es recomendable disminuir la ingesta de líquidos desde 2 horas antes de dormir.

Las infecciones de orina pueden ser frecuentes. Es importante aprender a reconocerlas y solicitar consulta médica cuando se sospeche para un manejo adecuado.
En caso de dificultad en la micción, hay ejercicios que pueden ayudar a inducirla.

Estreñimiento: No es necesario hacer deposición diariamente, y se considera normal a partir de 3 veces por semana. La dieta rica en fibra y líquido es fundamentar para su prevención. La mejor posición para defecar es apoyando los pies en una banqueta, para que las rodillas queden más altas que las caderas. Establecer una rutina diaria, por ejemplo, intentar hacer deposición después de una comida principal, ya que es el momento en el cual el intestino es más activo.

3. Hábitos tóxicos:

Evitar el consumo de tabaco: es el principal factor de riesgo modificable identificado. Se relaciona tanto con la aparición como con la progresión de la enfermedad.

Evitar el consumo de alcohol debido a los efectos nocivos sobre el sistema nervioso e interacción con los fármacos.

Cualquiera de las drogas ilegales ha demostrado daño sobre el sistema nervioso central a corto y largo plazo, con complicaciones que en muchos casos resultan irreversibles. Su uso por está siempre contraindicado. Existen algunos fármacos derivados de cannabinoides que han demostrado beneficio para algunos síntomas concretos. Para que sean realmente útiles y no ocasionen otros problemas mayores precisan la indicación y control por parte del médico.

4. Nutrición y Dieta

Dieta balanceada: Comer una dieta saludable, rica en frutas, verduras, proteínas magras y grasas saludables, puede mejorar la energía y la salud general. Evitar consumo de azúcares refinados y grasas saturadas.

Hidratación: Mantenerse bien hidratado es importante, ya que la deshidratación puede empeorar la fatiga y otros síntomas.

Suplementos: Algunos pacientes con EM pueden beneficiarse de suplementos como vitamina D. La deficiencia de esta vitamina se asocia con una progresión más rápida de la enfermedad. Siempre es importante consultar al médico antes de tomar cualquier suplemento.

5. Ejercicio y Movilidad

Ejercicio adaptado: Consultar con un fisioterapeuta o entrenador especializado para desarrollar un plan de ejercicio adaptado a las necesidades individuales. Ejercicios suaves, como caminar, nadar o hacer estiramientos, pueden mejorar la fuerza, la movilidad el equilibrio y coordinación de los movimientos. Puede ser de ayuda concentrarse en los movimientos que se va a hacer y mantener la vista en un punto durante el movimiento.

Evitar caídas: Dado que la enfermedad puede afectar el equilibrio, usar dispositivos de apoyo, como bastones o andadores, puede ser necesario en algunos pacientes para evitar caídas. Dan más seguridad y permiten mantener la autonomía durante más tiempo.

Los temblores disminuyen añadiendo un pequeño peso mediante brazaletes o tobilleras. Usarlos demasiado tiempo puede incrementar la fatiga.

6. Educación y auto-empoderamiento

Conocer la enfermedad: Informarse sobre la esclerosis múltiple, sus síntomas, tratamientos y avances en la investigación puede ayudar a reducir el miedo y aumentar la autonomía.

Participar en decisiones médicas: Ser parte activa en el proceso de toma de decisiones sobre el tratamiento y la atención médica.

7. Adherencia al tratamiento

Cumplimiento del tratamiento: Seguir las indicaciones médicas para asegurar que el tratamiento de la EM sea efectivo. Los medicamentos ayudan a controlar los síntomas y ralentizar la progresión de la enfermedad.

Educación sobre los efectos secundarios: Es útil conocer los posibles efectos secundarios de los medicamentos, para poder comunicarlos al médico y hacer ajustes si es necesario.

8. Vigilancia de los síntomas

Seguimiento médico regular: Mantener consultas regulares con un neurólogo para evaluar el progreso de la enfermedad y ajustar el tratamiento según sea necesario.

Atención a los síntomas: Es importante estar alerta a los cambios en los síntomas y notificar al médico si se experimentan nuevos problemas o un empeoramiento de los existentes.

9. Manejo del Estrés

Técnicas de relajación: La meditación, la respiración profunda, el yoga y la atención plena (mindfulness) son útiles para reducir el estrés y la ansiedad que empeoran los síntomas de la EM.

Descanso adecuado: El descanso y la relajación son clave. Tener un horario de descanso regular y evitar el sobreesfuerzo es fundamental.

Actividad física moderada: Mantenerse activo mediante la realización de ejercicios adecuados y no extenuantes (por ejemplo, el yoga y el taichí) puede ayudar a reducir la fatiga y mejorar el estado de ánimo.

10. Cuidado emocional y psicológico

Apoyo psicológico: Hablar con un terapeuta o un consejero puede ayudar a manejar las emociones difíciles que pueden surgir debido a los desafíos de vivir con la enfermedad.

Grupos de apoyo: Unirse a grupos de apoyo para personas con EM puede ser útil para compartir experiencias, reducir el aislamiento y obtener consejos prácticos de quienes enfrentan situaciones similares.

Aceptar los cambios: La EM puede causar cambios físicos y emocionales. Aceptar y adaptarse a estos cambios, con el apoyo adecuado, es esencial para el bienestar emocional.

11. *Mens sana in corpore sano*:

Mantener la mente activa. El estudio, la lectura, las aficiones, actividades culturales como el cine, teatro y los pasatiempos artísticos ayudan a protegerse de los problemas cognitivos asociados a la enfermedad y evitar el aislamiento.

12. Modificación del Entorno

Adaptación del hogar: Hacer modificaciones en el hogar como colocar pasamanos, mejorar la iluminación, eliminar obstáculos y crear espacios adaptados, puede facilitar la movilidad y mejorar la seguridad.

Adaptación laboral: con horarios flexibles, reubicación de puesto de trabajo o teletrabajo.

Tecnología asistida: Existen dispositivos como sillas de ruedas eléctricas, ayudas para la escritura y aplicaciones que pueden facilitar las tareas diarias y mejorar la calidad de vida en aquellos pacientes que lo necesitan.

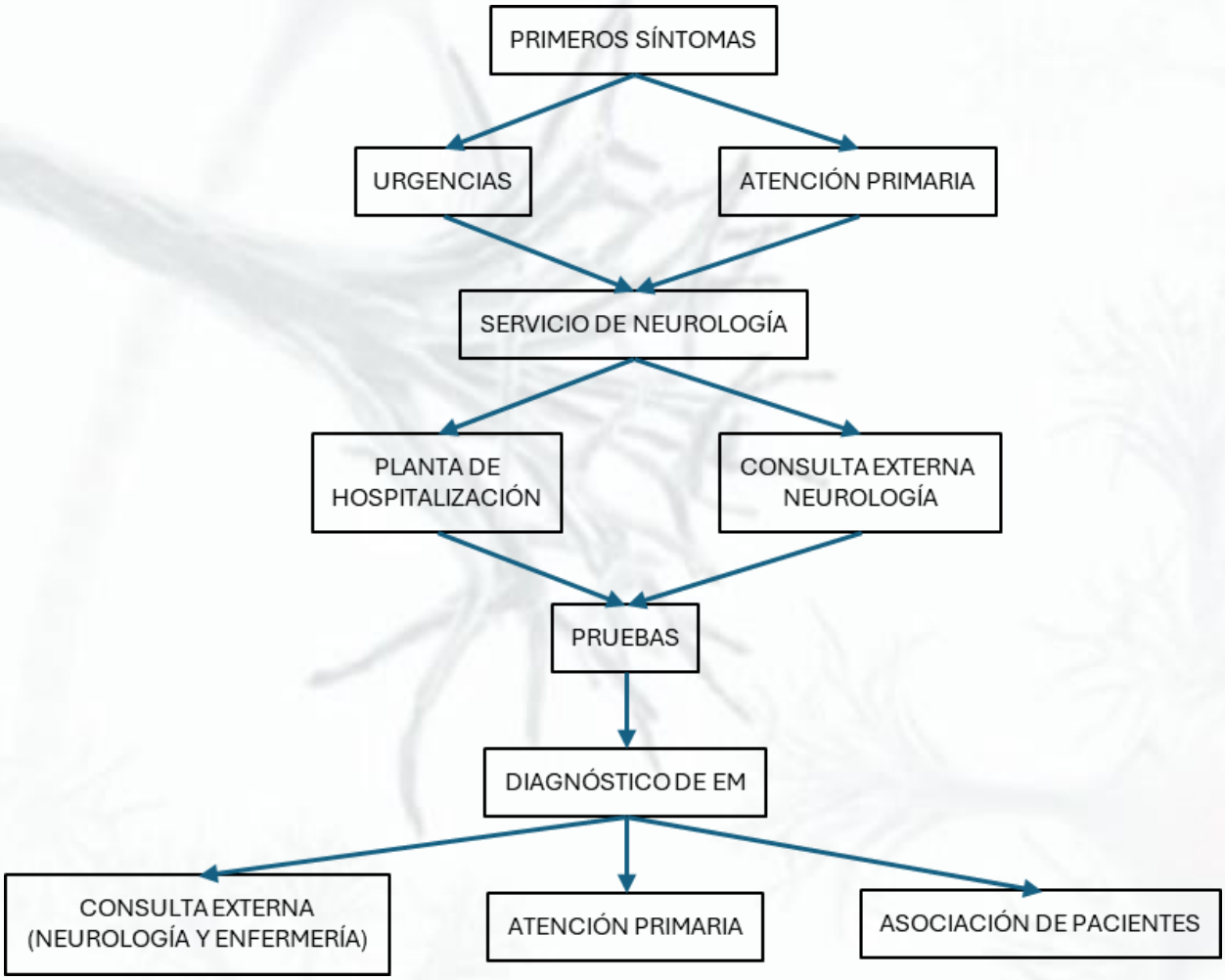
13. Cuidado de la piel

Higiene de la piel: Cuando hay disminución de la movilidad o la sensibilidad, es muy importante mantener la piel limpia y bien hidratada para prevenir úlceras o irritaciones.

Cuidado de los pies: Prestar atención a la salud de los pies, ya que pueden verse afectados por problemas de circulación o movilidad.

Estas pautas de autocuidado pueden ayudar a las personas con esclerosis múltiple a llevar una vida más saludable, equilibrada y con mayor control sobre su bienestar. Es importante personalizar estas estrategias con la ayuda de un equipo médico especializado, ya que cada persona con EM tiene experiencias y necesidades únicas.

8. PRÁCTICA CLÍNICA HABITUAL EN LA UNIDAD DE ENFERMEDADES DESMIELINIZANTES DEL CHUA.



Seguimiento del paciente:

- Revisión por parte del neurólogo: a los tres meses y seis meses al inicio del tratamiento. Posteriormente según evolución.
- Analíticas de control: al mes, 3 meses y 6 meses posteriores al inicio del tratamiento y previa a la consulta médica.
- Realización de RM: una vez al año o si empeoramiento, según necesidad.
- Realización de otras pruebas diagnósticas o derivación a otras especialidades que se realizaran de forma individualizada según las necesidades del paciente.
- Estudio funcional: debido a la variabilidad y la multiplicidad de los síntomas tanto funcionales como cognitivos que pueden presentar los pacientes con EM, es necesario realizar una monitorización objetiva de estos. Permite hacer un seguimiento adecuado de la evolución de la enfermedad. Existen múltiples escalas validadas que se pasan en esa visita.

Protocolo de enfermería en el seguimiento del paciente:

- Educación para el inicio del tratamiento: información y formación al paciente y familiar o cuidador sobre el tratamiento. Enseñanza de la técnica de inyectables subcutáneos y manejo de autoinyectores.
- Manejo de posibles efectos secundarios de los tratamientos.
- Extracción de analíticas especiales (VJC, neurofilamentos, genotipado).
- Resolución de dudas y acompañamiento.
- Valoración de posibles síntomas asociados a la EM.
- Establecer planes de cuidados y hábitos saludables para mejorar la calidad de vida de la persona con EM.
- Identificar posibles problemas de adherencia en el tratamiento.

¿Qué puedo hacer ante la sospecha de un brote?

- Esto debe ser confirmado por un neurólogo mediante una exploración neurológica de cara a valorar si hay indicación de tratamiento antiinflamatorio lo más precoz posible.
- Nuestra recomendación en estos casos es contactar por teléfono con la enfermera de neurología (ver datos de contacto más adelante) que organizará la valoración del paciente en la consulta mediante una cita con su neurólogo responsable.
- Excepcionalmente, en caso de que esto no sea posible, el paciente será valorado por otro neurólogo del servicio en la consulta o será derivado a urgencias para valoración por el neurólogo de guardia.

CONTACTO SERVICIO DE NEUROLOGÍA:

Enfermera de Neurología:

Teléfono: 638 22 60 02 // 967 59 74 93

Secretaría de Neurología:

Teléfono**:** 967597165

Correo electrónico servicio de Neurología: neurologia.gaiab@sescam.jccm.es

9. ASOCIACIONES DE PACIENTES.

Las asociaciones disponen de profesionales que pueden ayudar tanto a las personas con esclerosis múltiple como a sus familiares o cuidadores. Ofrecen distintos tipos de apoyo y servicios como pueden ser:

a. Servicio de rehabilitación, logopedia, terapia ocupacional, psicología, etc.
b. Orientación sobre aspectos legales y laborales.
c. Programas de ayuda a domicilio.
d. Grupos de apoyo.

1. En Albacete contamos con la Asociación Española de Esclerosis Múltiple de Albacete en
    - **CIEN** (Centro Integral de Enfermedades Neurológicas) https://emalbacete.es
2. A nivel nacional algunas de las asociaciones disponibles son:
    - **Esclerosis Múltiple España (EME)** https://www.emes.org.es
    - **Asociación de Esclerosis Múltiple de Madrid (AEMM)** https://www.aemmadrid.org
3. A nivel internacional:
    - **Multiple Sclerosis Foundation (MSF)** https://msfocus.org
    - **Multiple Sclerosis International Federation (MSIF)** https://www.msif.org
    - National Multiple Sclerosis Society (NMSS) https://www.nationalmssociety.org
        - En el apartado “programas informativos y biblioteca” posteriormente en “Pathways to Wellness in MS” existe material sobre nutrición, ejercicio, bienestar emocional, espiritual y social.

Bibliografía

1. Marck CH, De Livera AM, Brown CR, Neate SL, Taylor KL, Weiland TJ, et al. Health outcomes and adherence to a healthy lifestyle after a multimodal intervention in people with multiple sclerosis: Three-year follow-up. PLoS One. 23 may 2018; 13(5):e0197759.
2. Observatorio Esclerosis Múltiple. Barcelona (España): Fundacio Esclerosi Multiple (FEM); c2013-2019 Disponible en: https://www.observatorioesclerosismultiple.com/es/
3. Clínica Universidad de Navarra [Internet]. Pamplona (España): Clinica Universidad de Navarra; c2019. Cuidados en un paciente con esclerosis multiple; Disponible en: http://www.cun.es/area-salud/salud/cuidados-casa/cuidados-pacienteesclerosis- multiple
4. Vilardell T. Alimentacion y EM. Madrid (España): Federacion Espanola Para la Lucha contra la Esclerosis Multiple (FELEM); 2010.
5. Multiple Sclerosis Society. "Living with Multiple Sclerosis: A Guide for Patients." Disponible en: www.mssociety.org
6. National Multiple Sclerosis Society. "Healthy Living with MS." Disponible en: www.nationalmssociety.org
7. Mayo Clinic. "Multiple Sclerosis Care at Mayo Clinic." Disponible en: www.mayoclinic.org
8. Compston, A., & Coles, A. (2008). "Multiple sclerosis." *Lancet*, 372(9648), 1502-1517.
9. Campbell, J. D., Ghushchyan, V., et al. (2014). "Burden of Multiple Sclerosis on Health-Related Quality of Life." *PharmacoEconomics*, 32(7), 601-612.